

Menopausia y climaterio

1. Introducción y relevancia clínica

La **menopausia** es el **cese definitivo de la menstruación** debido al agotamiento folicular ovárico, confirmada tras **12 meses consecutivos sin sangrado**.

Marca el fin de la vida reproductiva y ocurre en promedio a los **50 años** (rango 45–55) en la mujer chilena.

El **climaterio** es un período más amplio que comprende la **transición desde la vida reproductiva hasta la no reproductiva**, abarcando los años **previos y posteriores a la menopausia**.

Durante este tiempo ocurren **cambios endocrinos, físicos y emocionales** asociados a la disminución de estrógenos.

La menopausia es un fenómeno fisiológico, pero puede generar síntomas que **afectan significativamente la calidad de vida** y aumentan el riesgo de **osteoporosis, enfermedad cardiovascular y trastornos urogenitales**.

□ En EUNACOM: suelen preguntar diferencias entre *menopausia* y *climaterio*, el *marcador hormonal característico (FSH alta)*, y las *indicaciones de terapia hormonal de reemplazo (THR)*.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Cambios endocrinos

Con el envejecimiento ovárico:

- Disminuye el número de folículos primordiales.
- Se reduce la secreción de **inhibina B** y **estradiol**.
- Aumenta la secreción hipofisaria de **FSH** y **LH** (por falta de retroalimentación negativa).

El resultado es una **anovulación crónica** y, posteriormente, **falla ovárica completa**.

Hormona	Tendencia en menopausia
Estradiol (E2)	↓↓↓ (<20 pg/mL)
Progesterona	↓
FSH	↑↑ (>40 mUI/mL)
LH	↑
Andrógenos (testosterona)	Leve ↓

☐ La **FSH >40 mUI/mL** es el marcador bioquímico más característico de la menopausia.

b. Cambios fisiológicos y tisulares

La falta de estrógenos afecta múltiples sistemas:

Sistema	Cambios característicos
Reproductivo	Atrofia vaginal, disminución lubricación, acortamiento del canal vaginal
Cutáneo	Disminución colágeno, elasticidad, arrugas
Osteoarticular	Aumento reabsorción ósea → osteoporosis
Cardiovascular	Pérdida del efecto protector estrogénico, ↑ riesgo de ECV

Neurológico Cambios del ánimo, insomnio, pérdida cognitiva leve

Metabólico Aumento resistencia insulínica, grasa visceral

3. Clínica

a.

Síntomas vasomotores

- **Sofocos (bochornos):** sensación súbita de calor con rubor facial y sudoración.
- **Sudoración nocturna** → insomnio y fatiga.
- Se deben a la **inestabilidad del centro termorregulador hipotalámico** inducida por déficit estrogénico.

b.

Síntomas genitourinarios

- Sequedad vaginal, dispareunia.
- Polaquiuria, urgencia, infecciones urinarias recurrentes (síndrome genitourinario de la menopausia).

c.

Síntomas psicológicos y del ánimo

- Irritabilidad, ansiedad, labilidad emocional.
- Dificultad para concentrarse, insomnio.

d.

Cambios somáticos

- Aumento de peso, principalmente abdominal.
- Dolor articular, disminución de masa muscular.

e.

Manifestaciones crónicas

- Osteoporosis y fracturas por fragilidad.
- Mayor riesgo cardiovascular (ateroesclerosis, dislipidemia).

4. Diagnóstico

a. Clínico

- Mujer entre 45 y 55 años con **amenorrea ≥ 12 meses** y síntomas vasomotores.
- No requiere exámenes complementarios en mujeres mayores de 45 años con síntomas típicos.

b. Laboratorio

Solicitar FSH y estradiol **solo si hay dudas diagnósticas**, por ejemplo:

- Menopausia precoz (<40 años).
- Uso de anticonceptivos hormonales.
- Histerectomía previa sin ovariectomía.

Examen	Resultado
--------	-----------

FSH	>40 mUI/mL
-----	------------

Estradiol	<20 pg/mL
-----------	-----------

En mujeres con útero intacto y amenorrea prolongada sin THR, la elevación persistente de FSH confirma el diagnóstico.

5. Clasificación temporal del climaterio

Etapa	Características clínicas	Duración aproximada
Perimenopausia	Ciclos irregulares, síntomas vasomotores, anovulación intermitente	2–8 años
Menopausia	Última menstruación confirmada tras 12 meses de amenorrea	Evento puntual
Posmenopausia temprana	Primeros 5 años tras menopausia, síntomas intensos	5 años
Posmenopausia tardía	>5 años postmenopausia, riesgo cardiovascular y óseo	Resto de la vida

6. Complicaciones

Sistema	Complicación	Comentario
Óseo	Osteoporosis y fracturas	Riesgo mayor en IMC bajo o menopausia precoz
Cardiovascular	Aumento aterogénesis	Pérdida del efecto vasodilatador estrogénico

Urogenital	Atrofia vaginal, infecciones urinarias	Por pérdida de epitelio y pH ácido
Cognitivo	Deterioro leve, depresión	Multifactorial
Cutáneo	Pérdida de colágeno	Envejecimiento cutáneo acelerado

7. Tratamiento

El tratamiento debe ser **individualizado**, considerando síntomas, edad, comorbilidades y riesgo cardiovascular.

a. Medidas generales

- Ejercicio físico regular (aeróbico y resistencia).
 - Dieta rica en calcio (1.200 mg/día) y vitamina D (800 UI/día).
 - No fumar, evitar alcohol en exceso.
 - Mantener peso adecuado y salud ósea.
 - Apoyo psicológico y educación.
-

b. Terapia hormonal de reemplazo (THR)

1. Indicaciones

- Síntomas vasomotores moderados o severos que afectan calidad de vida.
- Síndrome genitourinario severo no controlado con terapia local.
- Prevención de osteoporosis en mujeres <60 años con alto riesgo y sin contraindicaciones.

2. Contraindicaciones

Absolutas:

- Cáncer de mama o endometrial activo o previo.
- Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar.
- Enfermedad hepática activa.
- Sangrado uterino sin diagnóstico.

Relativas:

- Migraña con aura.
- Antecedente familiar de cáncer de mama.
- Hipertensión o dislipidemia no controlada.

3. Esquemas terapéuticos

Situación	Esquema	Objetivo
Útero intacto	Estrógeno + progestágeno cíclico o continuo	Evitar hiperplasia endometrial
Histerectomía	Estrógeno solo	No requiere progestágeno
Síntomas locales aislados	Estrógeno vaginal (óvulos, crema)	Manejo de atrofia vaginal

En Chile, los preparados orales y transdérmicos más usados son:

- **Estradiol + acetato de medroxiprogesterona** (Climodien®, Activelle®).
- **Estrógenos conjugados + medroxiprogesterona** (Premarin®, Prempro®).
- **Estradiol transdérmico + progesterona micronizada.**

4. Duración

- Se recomienda la dosis **mínima eficaz durante el menor tiempo posible** (idealmente <5 años).
 - Reevaluar anualmente indicación y riesgos.
-

c. Alternativas no hormonales

Grupo	Ejemplo	Eficacia
ISRS / IRSN	Paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina	Mejoran sofocos leves a moderados
Gabapentina / clonidina	—	Sofocos moderados
Fitoestrógenos (soya, isoflavonas)	—	Efecto leve
Lubricantes vaginales	Gel o crema	Síntomas locales leves

8. Prevención de complicaciones crónicas

1. Osteoporosis:

- Densitometría ósea (DXA) en >65 años o <65 con factores de riesgo.
- Suplementos + ejercicio + THR o bifosfonatos según caso.

2. Cardiovascular:

- Control de HTA, dislipidemia, diabetes.
- Evitar THR en mujeres >60 años o >10 años postmenopausia.

3. **Cáncer ginecológico:**

- Control ginecológico anual, mamografía bianual.
- Papanicolaou según norma MINSAL.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Menopausia:** 12 meses sin menstruación.
2. **Climaterio:** periodo de transición antes y después de la menopausia.
3. **FSH elevada (>40 mUI/mL)** y **estradiol bajo** confirman diagnóstico.
4. **Síntoma más frecuente:** sofocos.
5. **Terapia hormonal de reemplazo (THR)** indicada en síntomas moderados-severos sin contraindicaciones.
6. **Estrógeno + progestágeno** si útero intacto; **estrógeno solo** si histerectomía.
7. **Contraindicaciones absolutas:** cáncer de mama, trombosis, sangrado no aclarado.



Errores comunes

- Iniciar THR sin descartar patología endometrial.
 - Usar estrógeno solo en mujeres con útero.
 - Suspender abruptamente la terapia sin seguimiento.
 - Indicar THR solo para prevenir osteoporosis.
 - No ofrecer alternativas no hormonales en mujeres de alto riesgo.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Menopausia:** cese definitivo de menstruación ≥ 12 meses; **climaterio** es la transición perimenopáusica.
2. Se debe a la **falla ovárica fisiológica** $\rightarrow \downarrow$ estrógenos, $\uparrow$ FSH y LH.
3. Principales síntomas: **sofocos, trastornos del sueño, atrofia vaginal y cambios del ánimo.**
4. **Diagnóstico clínico;** FSH solo si hay duda o menopausia precoz.
5. **THR** es el tratamiento más eficaz, siempre individualizado y con evaluación de riesgos.
6. **Estrógeno + progestágeno** si útero presente; **estrógeno solo** si histerectomizada.
7. Prevención de **osteoporosis y riesgo cardiovascular** es parte del manejo integral.